TRÊS ROTEIROS DE REELS

Gravação simples com celular: vertical, tripé, luz natural de frente e fala em tom de conversa. Edite no próprio Instagram ou no CapCut, usando as fontes da marca (Jost e Inter) nos textos da tela, quando possível.

REELS 1 — O QUE É REABILITAÇÃO ORAL E QUANDO ELA PODE SER NECESSÁRIA?

Duração estimada: 45 a 60 segundos · **Capa pronta:** `CAPAS/capa_reels01.png` (no Instagram: Editar capa → Adicionar da galeria)

Gancho inicial (primeiros 3 segundos): “Reabilitação oral não é só deixar o sorriso bonito.”

Texto completo da fala

TEMPO	FALA
0–4 s	Reabilitação oral não é só deixar o sorriso bonito.
4–14 s	Reabilitar é devolver para a boca aquilo que foi perdido: a capacidade de mastigar bem, o conforto e a harmonia do sorriso.
14–26 s	Ela pode ser necessária quando a pessoa perde um ou mais dentes, quando os dentes estão muito desgastados ou fraturados, ou quando a prótese já não se adapta.
26–38 s	E isso não é só estética: estudos mostram que a perda dentária afeta a qualidade de vida, a mastigação, a fala e a autoestima.
38–50 s	Por isso, cada plano é individual. Pode envolver restaurações, cirurgias, implantes e próteses, sempre em etapas bem planejadas.
50–58 s	Se você sente que o seu sorriso já não funciona como antes, o primeiro passo é uma avaliação. Me chama no link da bio.

Orientação de gravação: Celular na vertical, na altura dos olhos, apoiado em tripé. Luz natural de frente (janela à frente da Dra., nunca atrás). Fundo do consultório limpo, em tons claros. Jaleco branco. Fale olhando para a lente, em tom de conversa, como se explicasse para um paciente.

Sugestão de cenas

- Plano médio da Dra. falando para a câmera (cena principal).
- Cortes de 2 a 3 segundos: mãos organizando instrumentais, detalhe do jaleco com o nome, a Dra. explicando um modelo ou uma radiografia na tela (sem dados do paciente).

- Fechamento com a Dra. sorrindo e o símbolo da marca na tela.

Textos na tela

- REABILITAÇÃO ORAL
- Função · Conforto · Harmonia
- Perda de dentes · Desgastes · Fraturas · Próteses antigas
- Cada plano é individual
- Agende sua avaliação · link na bio

Legenda

> Reabilitação oral é devolver função, conforto e harmonia ao sorriso. Ela pode ser indicada quando há perda de dentes, desgastes, fraturas ou próteses que não se adaptam mais, e o plano é sempre individual.
>
> Salve este vídeo e envie para alguém que está adiando esse cuidado.
>
> Dra. Tatiane Aislan · Cirurgiã-Dentista · CRO-BA 32044
> 📍 Salvador e Lauro de Freitas – BA
>
> #reabilitacaooral #implantesdentarios #protesedentaria #odontologia #dentista #saudebucal

CTA final: Me chama no link da bio para agendar sua avaliação.

Referências: Gerritsen AE, Allen PF, Witter DJ, Bronkhorst EM, Creugers NHJ. Tooth loss and oral health-related quality of life: a systematic review and meta-analysis. Health Qual Life Outcomes. 2010;8:126. https://doi.org/10.1186/1477-7525-8-126

REELS 2 — O CORPO PODE REJEITAR UM IMPLANTE DENTÁRIO?

Duração estimada: 35 a 45 segundos · **Capa pronta:** `CAPAS/capa_reels02.png` (no Instagram: Editar capa → Adicionar da galeria)

Gancho inicial (primeiros 3 segundos): "Será que o corpo pode rejeitar um implante, como acontece em um transplante?"

Texto completo da fala

TEMPO	FALA
0–4 s	Será que o corpo pode rejeitar um implante, como acontece em um transplante?
4–14 s	Essa é uma das dúvidas que eu mais escuto. E a resposta é: não da forma que muita gente imagina.
14–24 s	O implante não é um órgão. Ele é uma peça, geralmente de titânio, que se une ao osso por um processo chamado osseointegração.

TEMPO	FALA
24–34 s	Quando um implante falha, isso está ligado a outros fatores, como infecção nos tecidos ao redor, tabagismo, condições de saúde e falta de manutenção.
34–42 s	Por isso, planejamento, cuidado diário e consultas de acompanhamento fazem toda a diferença. Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários.

Orientação de gravação: Formato “pergunta e resposta”: a Dra. pode ler a pergunta em um cartão ou na tela do celular e depois responder olhando para a câmera. Celular na vertical, tripé, luz natural de frente. Áudio: grave em ambiente silencioso; se possível, use microfone de lapela.

Sugestão de cenas

- Abertura: a Dra. lendo a pergunta (plano fechado, expressão curiosa).
- Resposta em plano médio para a câmera.
- Insert: modelo/macro de implante em mãos (se disponível) ou ilustração simples na tela.
- Fechamento: a Dra. apontando para cima (comentários).

Textos na tela

- O CORPO PODE REJEITAR UM IMPLANTE?
- Implante não é órgão
- Osseointegração: o osso se une ao implante
- Fatores de falha: infecção · tabagismo · saúde geral · falta de manutenção
- Dúvidas? Comente aqui

Legenda

> O implante não sofre “rejeição” como um órgão transplantado: ele se integra ao osso por osseointegração. Quando há falha, outros fatores estão envolvidos, como infecção nos tecidos ao redor, tabagismo e falta de manutenção.
>
> Tem mais alguma dúvida sobre implantes? Deixe nos comentários.
>
> Dra. Tatiane Aislan · Cirurgiã-Dentista · CRO-BA 32044
> 📍 Salvador e Lauro de Freitas – BA
>
> #implantedentario #implantesdentarios #odontologia #dentista #saudebucal

CTA final: Deixe sua dúvida nos comentários e agende sua avaliação pelo link da bio.

Referências: Albrektsson T, Brånemark PI, Hansson HA, Lindström J. Osseointegrated titanium implants. Requirements for ensuring a long-lasting, direct bone-to-implant anchorage in man. Acta Orthop Scand. 1981;52(2):155-170. https://doi.org/10.3109/17453678108991776 | Berglundh T, Armitage G, Araujo MG, et al. Peri-implant diseases and conditions: Consensus report of workgroup 4 of the 2017 World Workshop. J Clin Periodontol. 2018;45(Suppl 20):S286-S291.

https://doi.org/10.1111/jcpe.12957 | Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A. Smoking and dental implants: A systematic review and meta-analysis. J Dent. 2015;43(5):487-498. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2015.03.003

REELS 3 — 3 ERROS COMUNS NA ESCOVAÇÃO

Duração estimada: 30 a 40 segundos · **Capa pronta:** `CAPAS/capa_reels03.png` (no Instagram: Editar capa → Adicionar da galeria)

Gancho inicial (primeiros 3 segundos): "Você escova os dentes todos os dias, mas pode estar cometendo pelo menos um destes três erros."

Texto completo da fala

TEMPO	FALA
0–5 s	Você escova os dentes todos os dias, mas pode estar cometendo pelo menos um destes três erros.
5–13 s	Erro número um: escovar com muita força. Quem remove a placa é a técnica, não a força. A escovação agressiva pode contribuir para desgaste e sensibilidade.
13–22 s	Erro número dois: esquecer de limpar entre os dentes. A escova não alcança esses espaços. Fio dental ou escova interdental fazem parte da rotina.
22–30 s	Erro número três: usar a mesma escova por tempo demais. O ideal é trocar a cada três a quatro meses, ou antes, se as cerdas abrirem.
30–36 s	Qual desses você comete? Conta aqui nos comentários e manda para alguém da família.

Orientação de gravação: Vídeo dinâmico, com cortes rápidos a cada erro. Grave na frente de um espelho ou da pia do consultório, com escova e fio dental nas mãos. Celular na vertical, luz natural. Use números grandes na tela (01, 02, 03) nas cores da marca.

Sugestão de cenas

- Gancho com a Dra. segurando a escova, olhando para a câmera.
- Erro 1: demonstração da pressão excessiva na mão (sem escovar de verdade) e, em seguida, o movimento correto e suave.
- Erro 2: a Dra. mostra o fio dental e a escova interdental.
- Erro 3: comparação entre uma escova nova e uma com cerdas abertas.
- Fechamento sorrindo.

Textos na tela

- 3 ERROS NA ESCOVAÇÃO
- 01 · Escovar com força
- 02 · Não limpar entre os dentes

- 03 · Não trocar a escova (3 a 4 meses)
- Qual é o seu? Comente

Legenda

> Três erros comuns na escovação:
> 1. Escovar com força: quem limpa é a técnica.
> 2. Não limpar entre os dentes: use fio dental ou escova interdental.
> 3. Não trocar a escova: o ideal é a cada 3 a 4 meses.
>
> Qual desses você comete? Conta nos comentários e compartilhe com a família.
>
> Dra. Tatiane Aislan · Cirurgiã-Dentista · CRO-BA 32044
> 📍 Salvador e Lauro de Freitas – BA
>
> #saudebucal #escovacao #prevencao #odontologia #dentista #sorrisosaudavel

CTA final: Comente qual erro você comete e compartilhe com alguém.

Referências: Canadian Advisory Board on Dentin Hypersensitivity. Consensus-based recommendations for the diagnosis and management of dentin hypersensitivity. J Can Dent Assoc. 2003;69(4):221-226. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12662460/ | Worthington HV, MacDonald L, Poklepovic Pericic T, et al. Home use of interdental cleaning devices, in addition to toothbrushing, for preventing and controlling periodontal diseases and dental caries. Cochrane Database Syst Rev. 2019;4:CD012018. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012018.pub2 | American Dental Association. Toothbrushes — Oral Health Topics. Chicago: ADA (página institucional, versão vigente). https://www.ada.org/resources/ada-library/oral-health-topics/toothbrushes